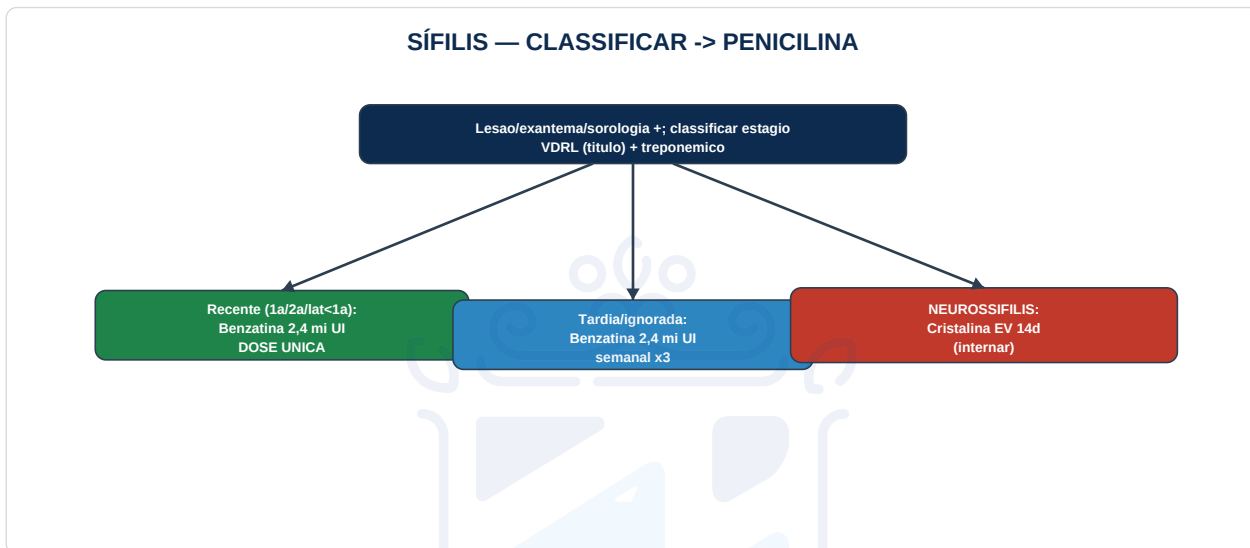


SÍFILIS — ESTÁGIO + PENICILINA BENZATINA

FLUXOGRAMA — ESTÁGIO GUIA O ESQUEMA



ESTÁGIOS CLÍNICOS

Estágio	Características
Primária	CANCRO DURO: úlcera genital única, INDOLOR, base limpa, bordas endurecidas + linfadenopatia regional (~3 sem)
Secundária	Exantema maculopapular PALMO-PLANTAR, roséola, condiloma plano, placas mucosas, alopecia em clareira + linfadenopatia generalizada (4-10 sem)
Latente	Sorologia + SEM sintomas: recente (< 1 ano) ou tardia (> 1 ano/ignorada)
Terciária	Gomas, sífilis cardiovascular (insuf. aórtica/aneurisma), neurosífilis tardia (tabes, demência)
Neurosífilis	QUALQUER estágio: meningite, AVC, uveíte, surdez (ou assintomática com alteração líquórica)

RED FLAGS — NEUROSSÍFILIS

EMERGÊNCIA

- Cefaleia intensa e persistente; rigidez de nuca (meningite sífilítica)
- Alteração VISUAL (uveíte, papilite, neurite óptica) ou AUDITIVA súbita
- Confusão mental/alteração de comportamento; déficit focal (AVC sífilítico); convulsões
- Coinfecção HIV + sífilis = maior risco de neurosífilis
- Sífilis cardiovascular: insuficiência aórtica, aneurisma de aorta; sífilis congênita sintomática no RN (hepatoesplenomegalia, pênfigo palmo-plantar, rinite, pseudoparalisia de Parrot)

DIAGNÓSTICO LABORATORIAL

NÃO-TREPONÊMICO + TREPONÊMICO

- NÃO-treponêmico (VDRL/RPR): rastreio e SEGUIMENTO (quantitativo, títulos); positiva 1-4 semanas após o cancro
- TREPONÊMICO (FTA-Abs, TPHA, teste rápido): confirmatório; positiva 2-3 semanas após o cancro; permanece positivo 'para sempre' (cicatriz) — NÃO serve para monitorar tratamento
- Diagnóstico: combinar os dois testes (um de cada tipo)
- Neurosífilis: punção lombar (VDRL no liquor, celularidade, proteína)
- Testar SEMPRE HIV, hepatites B e C; notificação compulsória (adquirida, gestante e congênita)

TRATAMENTO — PENICILINA É A BASE

Rx ESQUEMA POR ESTÁGIO

RECENTE (primária, secundária, latente < 1 ano): Penicilina G Benzatina 2.400.000 UI IM em DOSE ÚNICA (1,2 mi em cada glúteo) — NÃO repetir semanalmente

TARDIA (latente > 1 ano/ignorada, terciária exceto neuro): Penicilina G Benzatina 2.400.000 UI IM SEMANAL por 3 semanas (total 7,2 mi UI)

NEUROSSÍFILIS (qualquer estágio): Penicilina G Cristalina 18-24 mi UI/dia EV (3-4 mi 4/4h) por 14 dias — INTERNAR; alternativa: Procaína 2,4 mi IM/dia + Probenecida 14 dias

Alergia (não gestante): Doxiciclina 100 mg 12/12h por 14 dias (recente) ou 28 dias (tardia)

GESTANTE alérgica: DESSENSIBILIZAÇÃO (único tratamento eficaz para prevenir sífilis congênita) — encaminhar a referência

REAÇÃO DE JARISCH-HERXHEIMER: febre/calafrios/mialgia 2-24h após a 1ª dose (resposta à lise do treponema, NÃO é alergia) — tratar sintomático, não suspender; orientar antes

SEGUIMENTO, PARCEIROS E NOTIFICAÇÃO

PÓS-TRATAMENTO

- ☐ VDRL de controle em 3, 6, 12 e 24 meses; cura = queda de 2 diluições (ex.: 1:64 -> 1:16) em 6-12 meses (recente) ou 12-24 meses (tardia)
- ☐ VDRL pode não negativar ('cicatriz sorológica') — é normal; se não cair ou subir -> reinfecção/falha
- ☐ Convocar e TRATAR parceiros (tratamento epidemiológico, mesmo com sorologia negativa): últimos 3 meses (primária), 6 meses (secundária), 12 meses (latente)
- ☐ Notificação compulsória (SINAN): sífilis adquirida, em gestante e congênita
- ☐ INTERNAR: neurosífilis sintomática, sífilis congênita sintomática, gestante com complicações, Jarisch-Herxheimer grave, alergia na gestante (dessensibilização), HIV com neurosífilis

MODELO DE REGULAÇÃO / TRANSFERÊNCIA

RESUMO PARA REGULAÇÃO

- Paciente com sífilis estágio ____; VDRL ____, treponêmico ____; gestante ____ (IG ____).
- Neurosífilis: cefaleia/rigidez/visual/auditiva/foco/convulsão ____; PL ____; HIV ____.
- Conduta: Penicilina ____ (benzatina dose única / semanal x3 / cristalina EV) iniciada às ____; parceiro notificado ____.
- Solicito internação para Penicilina Cristalina EV (neurosífilis) / dessensibilização / seguimento de alto risco; notificar SINAN.

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

USP-SP / Adaptada

Qual é o tratamento da sífilis primária, secundária ou latente recente (< 1 ano)?

- A) Penicilina G Benzatina 2.400.000 UI IM em dose única
- B) Penicilina G Benzatina semanal por 3 semanas
- C) Penicilina Cristalina EV por 14 dias
- D) Azitromicina dose única
- E) Doxiciclina por 7 dias

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Qual achado dermatológico é muito sugestivo de sífilis secundária?

- A) Úlcera genital indolor
- B) Exantema maculopapular palmo-plantar
- C) Vesículas agrupadas
- D) Úlcera dolorosa purulenta
- E) Nódulo com fístula

QUESTÃO 3

SES-DF / Adaptada

Qual é o tratamento da neurosífilis?

- A) Penicilina Benzatina dose única
- B) Penicilina G Cristalina 18-24 milhões UI/dia EV por 14 dias (internação)
- C) Doxiciclina oral por 7 dias
- D) Azitromicina dose única
- E) Ceftriaxona IM dose única

QUESTÃO 4

UNIFESP / Adaptada

Gestante alérgica à penicilina com sífilis. Qual a conduta correta?

- A) Doxiciclina por 14 dias
- B) Dessensibilização à penicilina (único tratamento eficaz para prevenir sífilis congênita)
- C) Azitromicina
- D) Eritromicina por 14 dias
- E) Não tratar

QUESTÃO 5

UFRJ / Adaptada

A reação de Jarisch-Herxheimer após a primeira dose de penicilina é:

- A) Uma reação alérgica que exige suspender o antibiótico
- B) Resposta inflamatória à lise do treponema (febre/calafrios/mialgia); tratar sintomático sem suspender
- C) Sinal de falha terapêutica
- D) Indicação de troca para doxiciclina
- E) Sempre grave e fatal

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: A

Sífilis recente (primária, secundária ou latente < 1 ano) é tratada com Penicilina G Benzatina 2.400.000 UI IM em DOSE ÚNICA; a tardia usa o mesmo, porém semanal por 3 semanas.

QUESTÃO 2 → Resposta: B

O exantema maculopapular palmo-plantar é muito sugestivo de sífilis secundária, junto a roséola, condiloma plano e placas mucosas.

QUESTÃO 3 → Resposta: B

A neurosífilis (qualquer estágio) é tratada com Penicilina G Cristalina 18-24 milhões UI/dia EV por 14 dias, em regime de internação.

QUESTÃO 4 → Resposta: B

Na gestante alérgica, a dessensibilização à penicilina é o único tratamento eficaz para prevenir a sífilis congênita; alternativas (doxiciclina/eritromicina) não previnem a forma congênita.

QUESTÃO 5 → Resposta: B

A reação de Jarisch-Herxheimer é uma resposta inflamatória à destruição do treponema (febre, calafrios, mialgia), não uma alergia; trata-se de forma sintomática, sem suspender o antibiótico.

SM24
Suporte ao Plantão Médico